

Traducción no oficial del artículo "Continuity of care between hospital pharmacies and community pharmacies, and costs avoided: a pilot experience in times of Covid-19 in Spain" publicado en febrero 2021 en la revista GRHTA

Continuidad asistencial entre la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria, y costes evitados: una experiencia piloto en tiempos de la Covid-19 en España

Autores: Néboa Zozaya¹, Almudena González-Domínguez¹, Natividad Calvente², Rita de la Plaza³ Ana Herranz⁴, Antonio Blanes², Miguel Tamayo²

Afiliaciones:

1. Weber, Madrid, España. 2. Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Madrid, España. 3. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, Santander, España. 4. Vocal nacional de hospitales del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Madrid, España

Abstract:

Introducción. En marzo de 2020, debido a la pandemia causada por la Covid-19, se puso en marcha en Cantabria, una Comunidad Autónoma española, una experiencia piloto de continuidad asistencial en la atención farmacéutica de los pacientes externos hospitalarios. Gracias a esta experiencia, la medicación fue entregada en la farmacia comunitaria de elección del paciente. El objetivo de este trabajo es estimar los costes evitados por esta práctica durante los meses de abril y mayo de 2020.

Métodos. El análisis del impacto económico se realizó en términos de costes ahorrados, desde la perspectiva hospitalaria y desde la perspectiva social. Se calcularon los ahorros asociados con evitar la dispensación de medicamentos a domicilio y las pérdidas de productividad laboral evitadas por los pacientes, así como el tiempo asociado a los traslados evitados al hospital, en términos monetarios.

Resultados. Un total de 2.249 medicamentos de dispensación hospitalaria fueron entregados por la farmacia comunitaria en el periodo analizado, con un promedio de 57,7 entregas diarias. La experiencia, en la que participó un hospital y 262 farmacias de Cantabria, evitó a los pacientes 93.305 km en desplazamientos al hospital, asociados a un ahorro promedio de tiempo de 1.374 horas. En términos de costes, el hospital se evitó la realización de envíos por mensajería estimados en 30.205 euros, ya que fue la farmacia comunitaria y los almacenes distribuidores quienes se hicieron cargo de los mismos. Desde la perspectiva social, la iniciativa supuso un ahorro de 23.309 euros, gracias a los desplazamientos evitados (8.907 euros) y a las pérdidas de productividad evitadas (14.402 euros).

Conclusiones. Esta situación excepcional puede ser una buena oportunidad para acentuar la coordinación entre la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria en España, no solo durante la pandemia, sino también en la era post Covid-19.

Palabras clave: telepharmacy, community pharmacy, drugs delivery, continuity of care, Covid-19, Spain

Contexto

En marzo de 2020, la pandemia causada por el coronavirus SARS-Cov-2 (Covid-19) obligó a las autoridades españolas a confinar a la población, un hito sin precedentes en la historia reciente. El rápido aumento de contagios y hospitalizaciones ha provocado que el Sistema Nacional de Salud español viviera una presión asistencial desconocida hasta la fecha. El pico de la pandemia, alcanzado a mediados de abril, supuso la saturación de muchas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.

Esta situación obligó a poner en marcha, de una manera muy rápida, innovaciones organizativas que de otro modo habrían tardado años en hacerse realidad. Entre ellas, destacan los circuitos asistenciales paralelos, la flexibilización de los procesos, la realización de teleconsultas o las compras rápidas de materiales.

En España, un país de competencias sanitarias descentralizadas, algunos medicamentos de diagnóstico hospitalario son dispensados por la farmacia hospitalaria. Durante la pandemia por la Covid-19, algunos servicios autonómicos de salud incorporaron novedades en la dispensación de estos medicamentos. En este sentido, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) elaboró un protocolo de actuaciones a seguir en torno a la dispensación de medicación a pacientes externos, que recoge, entre otras medidas, fomentar la concertación de cita previa, ampliando horarios para espaciar las mismas; limitar la presencia y/o coincidencia de pacientes dentro del Servicio de Farmacia; y fomentar la entrega a domicilio para aquellos pacientes que se encuentren en aislamiento domiciliario por positivo de coronavirus o posible contagio (1).

Cantabria es una Comunidad Autónoma de unos 5.300 km² y 583.000 habitantes del norte de España que durante la realización del estudio contaba con 42 zonas básicas de salud, 4 hospitales públicos y 274 farmacias comunitarias (2,3). En esta comunidad se llevó a cabo durante la fase central de la pandemia una acción conjunta de continuidad asistencial entre la farmacia comunitaria (FC) y la farmacia hospitalaria, con el propósito de evitar el desplazamiento de los pacientes al hospital, para evitar posibles riesgos asociados. La experiencia piloto consistió en que, algunos de los medicamentos de dispensación hospitalaria suministrados en tres hospitales de Cantabria a pacientes externos fueron temporalmente remitidos a la farmacia comunitaria de elección del paciente, donde se le hacía una entrega informada del mismo. En todos los casos, el farmacéutico comunitario informó a los pacientes sobre la pauta posológica del medicamento. Por tanto, todas las entregas realizadas bajo esta iniciativa pueden considerarse entregas informadas.

El objetivo de este trabajo es estimar los costes evitados gracias a esta experiencia piloto de continuidad asistencial en la atención farmacéutica en Cantabria durante los meses de abril y mayo de 2020, desde la perspectiva del hospital y la perspectiva social.

Método

Para la experiencia piloto se elaboró un protocolo conjunto entre la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria que asegurara una correcta atención farmacéutica, distribución, dispensación, entrega y trazabilidad. El circuito establecido partía de la identificación de los pacientes susceptibles de involucrar en esta experiencia, siguiendo

el orden de citas concertadas para la consulta de atención farmacéutica en el hospital, que durante la pandemia pasó a ser telemática (4). Durante la consulta telefónica, se informaba al paciente de esta nueva posibilidad de envío de su medicación a la farmacia comunitaria, solicitando su consentimiento verbal. A efectos técnicos y legales, el hospital se mantuvo como responsable de la dispensación de estos medicamentos. La facilidad y bidireccionalidad de la comunicación de la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria fue uno de los ítems desarrollados en el protocolo.

Los datos analizados fueron facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, y corresponden al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el único para el que había suficiente información. La base recoge datos individualizados de los medicamentos dispensados bajo esta experiencia en la farmacia comunitaria de Cantabria durante los meses de abril y mayo de 2020.

El análisis del impacto económico de la iniciativa se realizó en términos de costes evitados desde dos perspectivas distintas: la del hospital y la social (Tabla 1).

Tabla 1. Descripción del tipo de coste, supuesto, método para su monetización y costes unitarios aplicados asociados a la iniciativa

TIPO DE COSTE EVITADO	SUPUESTO PARA SU IMPUTACIÓN	MONETIZACIÓN	COSTE UNITARIO APLICADO
Para el hospital: coste de los envíos evitados	Todos los envíos producidos	Coste estimado en base a si el medicamento requiere o no mantenimiento de la cadena de frío, considerando la posibilidad de agrupar en un solo paquete el envío de un mismo día a una misma FC	Tarifas de empresa externa de paquetería para envíos <1 kg no urgentes: 9,90€ sin frío y 20,04€ con mantenimiento de frío (5)
Para la sociedad: coste de los desplazamientos evitados	FC ubicada en un municipio distinto de el del hospital (Santander)	Coste estimado en función de los km de distancia entre el hospital y la FC	Tarifa oficial de Cantabria para los desplazamientos de pacientes: 0,10 €/km (6,7)
Para la sociedad: pérdidas de productividad laboral	FC ubicada a más de 1 km de distancia del hospital	Coste del tiempo evitado en desplazamientos, estimado en base a la renta disponible media ajustada por el tamaño del municipio	Renta disponible media por hora trabajada (supuesto de 37,5h/semana): entre 8,4€ y 12,9€ por hora (8)

Desde la perspectiva del hospital, el nuevo circuito, de carácter excepcional, fue totalmente altruista para el sistema sanitario público, ya que el coste de entrega del medicamento corrió a cargo de los almacenes distribuidores y de la farmacia comunitaria. El coste de los envíos domiciliarios de medicación evitados al hospital se calculó como el coste de tener que realizarlos a través de mensajería privada, teniendo en cuenta si el fármaco requería, o no, de mantenimiento de la cadena de frío (5). Los medicamentos entregados en un mismo día por una misma farmacia comunitaria se contabilizaron como un único envío desde el hospital.

Desde la perspectiva social, que contempla tanto el servicio cántabro de salud como la sociedad en general, solo se han tenido en cuenta dos tipos de costes: 1) aquellos asociados a los desplazamientos al hospital evitados a los pacientes, para recoger la medicación; y 2) las pérdidas de productividad laboral asociadas a ese tiempo que hubieran dedicado a dichos desplazamientos.

Para realizar el análisis, una vez depurada la información basal disponible, se extrajo la dirección exacta de cada farmacia comunitaria (2). Con ella, a través de *Google Maps*, se obtuvo la distancia exacta entre cada farmacia y el hospital, ubicado en Santander, la capital de Cantabria. A través de esta herramienta virtual se obtuvo también el tiempo promedio asociado a cada recorrido (en coche).

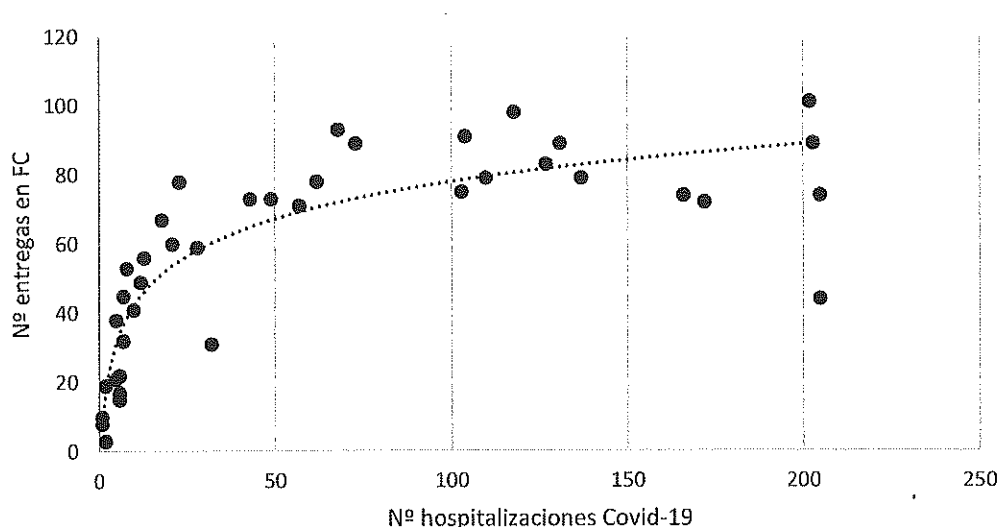
A partir de esta información, el coste asociado a los desplazamientos evitados por los pacientes se obtuvo aplicando la tarifa pública oficial de Cantabria (de 0,10 €/km) a los recorridos (de ida y de vuelta) realizados fuera de Santander (6,7). La pérdida de productividad laboral evitada se estimó monetizando los tiempos de los recorridos evitados, aplicando el coste/hora asociado a la renta disponible media, en función del tamaño del municipio donde estaba ubicada la farmacia comunitaria (8).

Resultados

Análisis descriptivo

La iniciativa piloto se asoció a la entrega informada de un total de 2.249 medicamentos en la farmacia comunitaria a lo largo de los 2 meses del análisis, con un promedio de 57,7 entregas diarias (DE 28,5). Se observa una evolución decreciente en el número de entregas informadas a lo largo del tiempo, en línea con la mejora producida en la pandemia (**Figura 1**). De hecho, existe una correlación del 66% entre el número de envíos diarios y la evolución de las hospitalizaciones por la Covid-19 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (9).

Figura 1. Relación del número de entregas en FC bajo esta iniciativa y del número de pacientes hospitalizados por la Covid-19 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, abril-mayo 2020



En la experiencia participaron 262 farmacias comunitarias, ubicadas en 86 de los 102 municipios de Cantabria (el 84%), las cuales atienden al 99,0% de la población de la Comunidad Autónoma. La mayor parte de las entregas (el 34,9% del total) se realizaron en las 85 farmacias ubicadas en Santander, el único municipio de más de 100.000 personas de la comunidad, donde se encuentra el 32% de las farmacias participantes en esta iniciativa. En las 65 farmacias del ámbito más rural (de menos de 5.000 habitantes) se produjeron casi una quinta parte de las entregas totales, obteniéndose la mayor ratio de entregas por habitante (Tabla 2).

Tabla 2. Análisis descriptivo de las entregas, por tamaño del municipio de la FC

Tamaño municipio	Nº de municipios		Nº FC		Nº entregas		Tasa promedio de entregas por 1.000 hab
	N	%	N	%	N	%	
100.001-500.000	1	1,2%	85	32,4%	784	34,9%	4,54
50.001-100.000	1	1,2%	22	8,4%	95	4,2%	1,84
20.001-50.000	3	3,5%	28	10,7%	327	14,5%	3,74
10.001-20.000	5	5,8%	24	9,2%	312	13,9%	4,64
5.001-10.000	11	12,8%	32	12,2%	300	13,3%	3,79
1.000-5.000	45	52,3%	51	19,5%	378	16,8%	3,78
<1.000	20	23,3%	20	7,6%	53	2,4%	4,76
TOTAL	86	100,0%	262	100,0%	2249	100,0%	4,04

El 53,05% de los medicamentos entregados requerían de mantenimiento de la cadena de frío. Por su parte, el 42,02% de las entregas fueron formas de administración por vía subcutánea, un porcentaje similar a las formas orales (41,35%)(Tabla 3).

Tabla 3. Distribución de los medicamentos entregados, por vía de administración y necesidad de cumplir con la cadena de frío

	SIN FRIO (n=1.056)	CON FRIO (n=1.193)	TOTAL (2.249)
Subcutánea	5,11%	74,69%	42,02%
Oral	84,85%	2,85%	41,35%
Intravenosa y subcutánea	0,95%	19,20%	10,63%
Otras combinaciones	6,72%	1,93%	4,18%
Otras formas*	2,37%	1,34%	1,82%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%

*Otras formas: Cutánea, inhalatoria, intestinal u oftálmica.

Dos terceras partes de los medicamentos entregados a través de esta iniciativa eran agentes antineoplásicos e inmunomoduladores (Tabla 4). Por su parte, el 59,7% de los fármacos eran de diagnóstico hospitalario, mientras que el 32,5% eran de uso hospitalario y el 7,8% restante eran medicamentos utilizados en situaciones especiales. La mayor parte de estos fármacos en situaciones especiales estaban dirigidos a patologías relacionadas con el sistema cardiovascular.

Tabla 4. Distribución de los medicamentos entregados, por código ATC1 (órgano o sistema en el cual actúa el fármaco) y tipo de prescripción

Código ATC1	Diagnóstico hospitalario	Uso hospitalario	Medicamentos en situaciones especiales	Total general
L - AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES	89,3%	27,9%	16,9%	63,7%
B - SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,7%	27,4%	0,6%	9,3%
J - ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO	0,8%	25,2%	1,7%	8,8%
C - SISTEMA CARDIOVASCULAR	1,8%	6,6%	57,1%	7,7%
N - SISTEMA NERVIOSO	1,4%	7,1%	3,4%	3,4%
A - TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO	0,8%	1,2%	16,9%	2,2%
H - PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYENDO HORMONAS SEXUALES E INSULINAS	1,3%	3,0%	1,7%	1,9%
R - SISTEMA RESPIRATORIO	2,0%	0,1%	0,6%	1,3%
S - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	1,4%	0,0%	0,0%	0,8%
G - SISTEMA GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES	0,0%	1,4%	0,0%	0,4%
D - DERMATOLÓGICOS	0,4%	0,0%	0,6%	0,3%
V - VARIOS	0,1%	0,0%	0,6%	0,1%
Total general	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

ATC: Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system.

Estimación de costes

Esta experiencia piloto de continuidad asistencial realizada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla evitó a los pacientes un total de 93.305 km en desplazamientos al hospital, contando con la ida y la vuelta al mismo. Estos desplazamientos evitados se asocian a un total de 1.374 horas. Por su parte, los desplazamientos evitados desde fuera del municipio de Santander se estiman en 89.073 km (Tabla 5).

Tabla 5. Estimación de los desplazamientos evitados y el tiempo asociado gracias a la iniciativa

Total desplazamientos evitados (km)*	93.305
Desplazamientos fuera de Santander evitados (km)	89.073
Tiempo asociado al total de desplazamientos evitados (h)	1.374

*Nota: no se tienen en cuenta las entregas en FC ubicadas a menos de 1km del hospital

Además, la iniciativa supuso la realización de 1.939 envíos por parte del hospital a la farmacia comunitaria (el 53,33% de ellos con servicios especiales de mantenimiento de la cadena de frío del medicamento). Desde la perspectiva hospitalaria, esta experiencia evitó al hospital realizar envíos por mensajería, estimados en 30.205 euros.

Desde la perspectiva social, la iniciativa supuso un ahorro total de 23.309 euros, gracias a los desplazamientos evitados (8.907 euros) y a las pérdidas de productividad evitadas (14.402 euros) (Extrapolada a un año, esta cifra de coste social evitado sería de en torno a 139.860 euros anuales.

Tabla 6). Extrapolada a un año, esta cifra de coste social evitado sería de en torno a 139.860 euros anuales.

Tabla 6. Estimación de los costes evitados por la iniciativa al hospital y a la sociedad

Perspectiva	Costes evitados	Cuantía
Hospital	Envíos de medicación a domicilio	30.205 €
Social	Desplazamientos evitados por los pacientes para el servicio cántabro de salud	8.907 €
	Pérdidas de productividad laboral evitadas	14.402 €
	TOTAL	23.309 €

En un análisis por subgrupos, el 58% de los 23.310 euros evitados desde la perspectiva social corresponderían a los medicamentos de diagnóstico hospitalario, mientras que un 35% estaría asociado a los medicamentos de uso hospitalario (**Tabla 7**). Por su parte, casi dos terceras partes de los costes sociales evitados por la iniciativa procederían de agentes antineoplásicos e inmunomoduladores (**Tabla 8**). Finalmente, atendiendo a la vía simplificada de administración, el 39% del coste social evitado correspondería a medicamentos de uso subcutáneo (**Tabla 9**).

Discusión

Cataluña, Andalucía, Aragón, La Rioja y Cantabria son algunas de las Comunidades Autónomas que implantaron circuitos de continuidad asistencial, organizando dispensaciones con la farmacia comunitaria (10–13). Hasta donde sabemos, este estudio es el primer análisis económico pormenorizado sobre el impacto económico y social de dicha experiencia que se ha publicado hasta la fecha en España. Esta iniciativa temporal de dispensación de medicamentos en la farmacia comunitaria permitió al hospital ahorrarse los costes de mensajería privada asociados a la entrega de medicamentos a domicilio, estimados en 30.205 euros en dos meses (lo que equivale al 0,04% del gasto farmacéutico hospitalario de Cantabria en abril y 20 de mayo (14)). La magnitud del impacto económico habría sido aún mayor si el estudio se hubiera extendido al 100% de los hospitales de Cantabria.

Durante la reciente pandemia causada por la Covid-19 en España, los servicios de farmacia hospitalaria se han visto obligados a reorganizarse para cubrir un escenario contradictorio. Por un lado, el Real Decreto del estado de alarma contemplaba como excepción salir de casa para recoger medicación, ya fuera en la farmacia comunitaria o en el hospital, pero, al mismo tiempo, las autoridades hacían llamamientos a la ciudadanía para no acudir a los entornos hospitalarios, evitando así la propagación del virus (15).

La crisis sanitaria causada por la pandemia ha supuesto un momento idóneo para implantar el reto asistencial que supone la telefarmacia dentro de las actividades tradicionales de la farmacia hospitalaria al paciente externo. En España, este enfoque de transformación se ha venido impulsando en gran medida dentro del denominado Mapa Estratégico para la Atención al Paciente Externo (MAPEX), si bien requería ajustes legales (16).

Antes de la crisis sanitaria, el 83,2% (IC95%: 77,1-88,3%) de los hospitales del SNS no realizaba ninguna actividad de atención farmacéutica no presencial que incluyera el envío de medicación (17). En cambio, en las seis primeras semanas de confinamiento, la dispensación no presencial se utilizó en más del 80% de los pacientes externos de los 41 centros hospitalarios analizados en el estudio de Tortajada et al. (2020). El procedimiento mayoritario fue la dispensación domiciliaria, con el 87% de los envíos, mientras que el 5,6% de las entregas se hicieron en coordinación con la farmacia comunitaria.

La iniciativa realizada en Cantabria que analizamos en este estudio arrancó en marzo de 2020 con 110 farmacias y el foco en ofrecer servicios a los pacientes más vulnerables (inmunodeprimidos, con problemas respiratorios o con problemas de movilidad). Al agravarse la situación sanitaria, el programa se extendió a todos los pacientes externos de la farmacia del hospital (18). Finalmente, prácticamente todas las farmacias comunitarias de la Comunidad Autónoma (262 de las 274 existentes) participaron en la iniciativa (19). El número promedio de medicamentos entregados a través de esta iniciativa de continuidad asistencial se cifra en unos 58 diarios, lo que supone más de un tercio de los dispensados ambulatoriamente por el servicio de farmacia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que atiende a unos 163 pacientes diarios (20). Del análisis se desprende que la mayor parte de los medicamentos entregados fueron agentes antineoplásicos e inmunomoduladores, poniendo de relieve que la iniciativa ayudó en gran parte a los pacientes más vulnerables. Otro aspecto a destacar es que casi el 8% de las entregas fueron fármacos dispensaciones en situaciones especiales.

Como hemos mostrado, esta experiencia piloto ha evitado a los pacientes desplazamientos innecesarios al hospital durante la crisis causada por la Covid-19. La iniciativa evitó que no solo el paciente, sino también sus cuidadores, tuvieran que desplazarse al hospital, con lo que ello conlleva en términos de costes de traslado y tiempo, especialmente si viven en las áreas más lejanas de la capital. Además, también podríamos hacer referencia a otras posibles ventajas de la iniciativa, que deberían ser

confirmadas en futuros estudios. Recoger el fármaco en la farmacia comunitaria podría haber permitido al paciente establecer un contacto más humanizado, personalizado y continuado con la persona que realiza la entrega que si lo hiciera un mensajero, beneficiándose del consejo farmacéutico. Esto podría haber redundado en una mayor seguridad, adherencia y cumplimiento terapéutico, aspectos especialmente claves de mantener durante una situación de crisis como la vivida, que obligó a retrasar el contacto directo continuado con el sistema. Otra ventaja potencial es el hecho de poder evitar al paciente el sufrimiento y miedo ocasionados por tener que acudir al hospital en plena pandemia, así como el riesgo ante un posible contagio. A esto se suma la flexibilidad de horarios que ofrece la farmacia comunitaria frente a la dispensación hospitalaria. Por todo ello, la iniciativa fue apoyada por el Foro Español de Pacientes (21).

Otros estudios apoyan nuestra afirmación de que una iniciativa de este tipo tendría muchos beneficios además del ahorro de costes. Una reciente encuesta interna realizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria revela el elevado grado de satisfacción mostrado por los pacientes participantes en la iniciativa. A más del 70% de los encuestados (n=61) les parecen adecuados o muy adecuados la accesibilidad, horarios y tiempo de espera en las farmacias comunitarias asignadas, y califican su nivel

Finalmente, la experiencia también podría haber permitido mejorar la coordinación entre la FH y la FC en los momentos más delicados de la pandemia. Una mejor coordinación podría evitar problemas relativos a los datos de envío del paciente o discrepancias entre la documentación y la medicación dispensada. Todo ello podría haber facilitado la trazabilidad de la distribución y dispensación del fármaco; manteniendo durante todo el proceso el fármaco dentro del canal farmacéutico; y evitando romper la cadena de frío del medicamento.

Nuestro estudio no está exento de limitaciones. Primero, los datos disponibles nos permitieron analizar la experiencia realizada en solo uno de los tres hospitales participantes, y solo durante los meses de abril y mayo. Sería conveniente ampliar el alcance del análisis a otros centros y horizontes temporales, para comprobar la consistencia y representatividad de los resultados. Segundo, carecemos de información sobre la edad o el grupo de edad de los pacientes, lo que nos habría permitido hacer supuestos más específicos y ajustados a la realidad, especialmente en lo que respecta a las pérdidas de productividad reales evitadas. Tercero, hemos considerado los costes promedio, pero los costes de transporte evitados pueden diferir en cierta medida de una región a otra. Finalmente, también habría sido deseable haber recopilado información sobre si el paciente se desplazaba acompañado por otra persona para computar el tiempo adicional evitado por el acompañante del paciente.

9

Referencias

1. SEFH. Procedimientos de Farmacia Hospitalaria para la gestión del tratamiento con antivirales en la enfermedad por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2 (Covid-19) [Internet]. [cited 2020 Aug 25]. Available from: https://www.sefh.es/fichadjuntos/200316Procedimientos_SEFH_COVID_19.pdf
2. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria. Farmacias en Cantabria [Internet]. [cited 2020 Aug 25]. Available from: <http://www.cofcantabria.org/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=df34e502-507b-494f-a119-68244e4a5d9c&Idioma=es-ES>
3. Instituto Cántabro de Estadística - ICANE [Internet]. [cited 2020 Aug 25]. Available from: <https://www.icane.es/>
4. BOE Núm. 163. Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 [Internet]. Available from: <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/con>
5. SEUR. Transporte de Paquetería y Mensajería Nacional e Internacional [Internet]. [cited 2020 Aug 31]. Available from: <https://www.seur.com/es/index.html>
6. BOC Número 98. Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la que se establece el régimen de ayudas para pacientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria y, en su caso, acompañantes, por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento con fines asistenciales [Internet]. Available from: <https://saludcantabria.es/uploads/pdf/ciudadania/OrdenDietasDesplazamientos.pdf>
7. BOC Número 15. Orden SAN/2/2019, de 7 de enero, por la que se modifica parcialmente la Orden SAN/27/2007, de 8 de mayo, por la que se establece el régimen de ayudas para pacientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria y, en su caso, acompañantes, por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento con fines asistenciales.
8. Agencia Tributaria. Estadística de los declarantes del IRPF por municipios: 2017. Renta bruta y renta disponible, por tamaño del municipio, en Cantabria [Internet]. 2017 [cited 2020 Aug 27]. Available from: https://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/irpfmunicipios/2017/jrubik4a3faf0b9aa1b07658e1550c41c8fedec8675f1e.html
9. Servicio Cántabro de Salud. Situación epidemiológica de la Covid-19 en Cantabria [Internet]. 2020 [cited 2020 Aug 27]. Available from: <https://www.scsalud.es/coronavirus>
10. Margusino-Framiñán L. Implantación de Consultas Externas Monográficas de Atención Farmacéutica en un Servicio de. Farm Hosp. 2017 Nov 1;(06):660–9.
11. El Global. El RD de “nueva normalidad” prolonga el envío de fármacos a domicilio desde hospitales [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 2]. Available from: <https://elglobal.es/farmacia/el-rd-de-nueva-normalidad-dara-continuidad-al-envio-de-medicamentos-a-domicilio-desde-hospitales/>
12. Servei Català de la Salut. Resolució per la qual, amb motiu de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s'estableixen mesures per a la dispensació de la medicació hospitalària de dispensació ambulatoria en la modalitat no presència [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 1]. Available from: <http://www.consorci.org/media/upload/arxiu/%C3%80rea%20Farm%C3%A0cia/CSC%20Info>

rma/CSC%20informa%2020.03.07/resolucio-dispensacio-MHDA-no-presencial-per-difusi%C3%B3.pdf

13. El CGCOF calcula que unos 7.000 pacientes recogen DH en farmacias [Internet]. DiarioFarma. 2020 [cited 2020 Sep 25]. Available from: <https://www.diariofarma.com/2020/05/27/el-cgcof-calcula-que-unos-7-000-pacientes-recogen-dh-en-farmacias>
14. Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre Gasto Farmacéutico y Sanitario [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 4]. Available from: <https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx>
15. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. BOE-A-2020-3692. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 20]. Available from: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463>
16. SEFH. Proyecto MAPEX: marco estratégico en telefarmacia [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 1]. Available from: https://www.sefh.es/mapex/images/Telefarmacia_SEFH.pdf
17. Tortajada-Goitia B. Encuesta de situación de la telefarmacia aplicada a la atención farmacéutica a pacientes externos de los servicios de farmacia hospitalaria en España durante la pandemia por la COVID-19. Farm Hosp. 2020;44(4):135–40.
18. Margusino-Framiñán L, Illarro-Uranga A, Lorenzo-Lorenzo K, Monte-Boquet E, Márquez-Saavedra E, Fernández-Bargiela N, et al. Atención farmacéutica al paciente externo durante la pandemia COVID-19. Telefarmacia. Farm Hosp. 2020;44(7):61–65–65.
19. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria. Farmacias y Botiquines [Internet]. [cited 2020 Sep 2]. Available from: <http://www.cofcantabria.org/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=97279c9c-579a-4714-859b-9e8c1fa7ea63&Idioma=es-ES>
20. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Memoria 2015 del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla [Internet]. 2016 [cited 2020 Aug 28]. Available from: http://www.humv.es/estatico/ua/farmacia_hospitalaria/mision_vision_valores/MEMORIA_FARMACIA_HOSPITALARIA.pdf-viejo
21. La farmacia comunitaria puede evitar desplazamientos de riesgo de infección por COVID-19 | SEFAC [Internet]. [cited 2020 Aug 24]. Available from: <https://www.sefac.org/sefac-opina/la-farmacia-comunitaria-puede-evitar-desplazamientos-de-riesgo-de-infeccion-por-covid>

TABLAS SUPLEMENTARIAS

Tabla 7. Distribución de los ahorros derivados por los desplazamientos evitados, según tipo de prescripción

Tipo de prescripción	Ahorros por los desplazamientos evitados		Pérdidas de productividad laboral evitadas	
	€	%	€	%
Diagnóstico hospitalario	5.132	57,6%	8.385	58,2%
Uso hospitalario	3.207	36,0%	4.986	34,6%
Medicamentos en situaciones especiales	568	6,4%	1.031	7,2%
Total	8.907	100%	14.402	100%

Tabla 8. Distribución de los ahorros derivados de los desplazamientos evitados, por código ATCI

Código ATCI	Ahorros por los desplazamientos evitados		Pérdidas de productividad laboral evitadas	
	€	%	€	%
A - Tracto alimentario y metabolismo	230	2,6%	343	2,4%
B - Sangre y órganos hematopoyéticos	996	11,2%	1.527	10,6%
C - Sistema cardiovascular	581	6,5%	1.034	7,2%
D - Dermatológicos	28	0,3%	47	0,3%
G - Sistema genitourinario y hormonas sexuales	23	0,3%	44	0,3%
H - Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e insulinas	220	2,5%	324	2,3%
J - Antiinfecciosos para uso sistémico	749	8,4%	1.208	8,4%
L - Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores	5.596	62,8%	9.081	63,1%
N - Sistema nervioso	283	3,2%	470	3,3%
R - Sistema respiratorio	126	1,4%	197	1,4%
S - Órganos de los sentidos	67	0,8%	117	0,8%
V - Varios	7	0,1%	10	0,1%
Total	8.907	100%	14.402	100%

Tabla 9. Distribución de los ahorros derivados de los desplazamientos evitados, por vía de administración

Vía de administración	Ahorros por los desplazamientos evitados		Pérdidas de productividad laboral evitadas	
	€	%	€	%
Oral	3.941	44%	6.255	43%
Intravenosa/subcutánea	1.078	12%	1.670	12%
Subcutánea	3.378	38%	5.654	39%
Otras formas	159	2%	263	2%
Otras combinaciones	355	4%	590	4%
Total	8.907	100%	14.402	100%